

Meningite bacteriana - conduta inicial

Suspeita de meningite bacteriana é emergência: estabilize, colete o que puder sem atrasar e inicie antibiótico empírico imediatamente.

Clínica por faixa etária

- Lactente: irritabilidade, febre, fontanela abaulada, recusa, convulsão — rigidez pode faltar
- Criança maior: febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, fotofobia, Kernig/Brudzinski
- Petéquias/púrpura: pensar meningococo — isolamento e ATB imediato

ATB empírico (ideia de prova)

Faixa | Esquema típico

Neonato | Ampicilina + cefotaxima (ou gentamicina conforme protocolo)

Lactente / criança | Ceftriaxona ou cefotaxima ± vancomicina (resistência pneumococo)

Imunocomprometido / risco *L. monocytogenes* | Associar ampicilina

Punção lombar

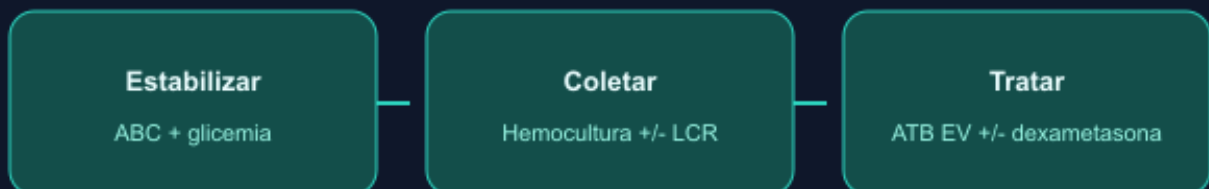
Lembre - Punção lombar

Se houver sinais de hipertensão intracraniana, instabilidade ou foco, faça imagem e NÃO atrase ATB — hemocultura + antibiótico primeiro.

Fluxo de prova: estabilizar !' coletar (se seguro) !' ATB ± corticoide.

Meningite bacteriana - 1a hora

Não atrase antibiótico



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Dexametasona (quando indicada) deve ser junto ou pouco antes da 1ª dose de ATB no pneumococo — atrasar perde o benefício na redução de sequelas.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1